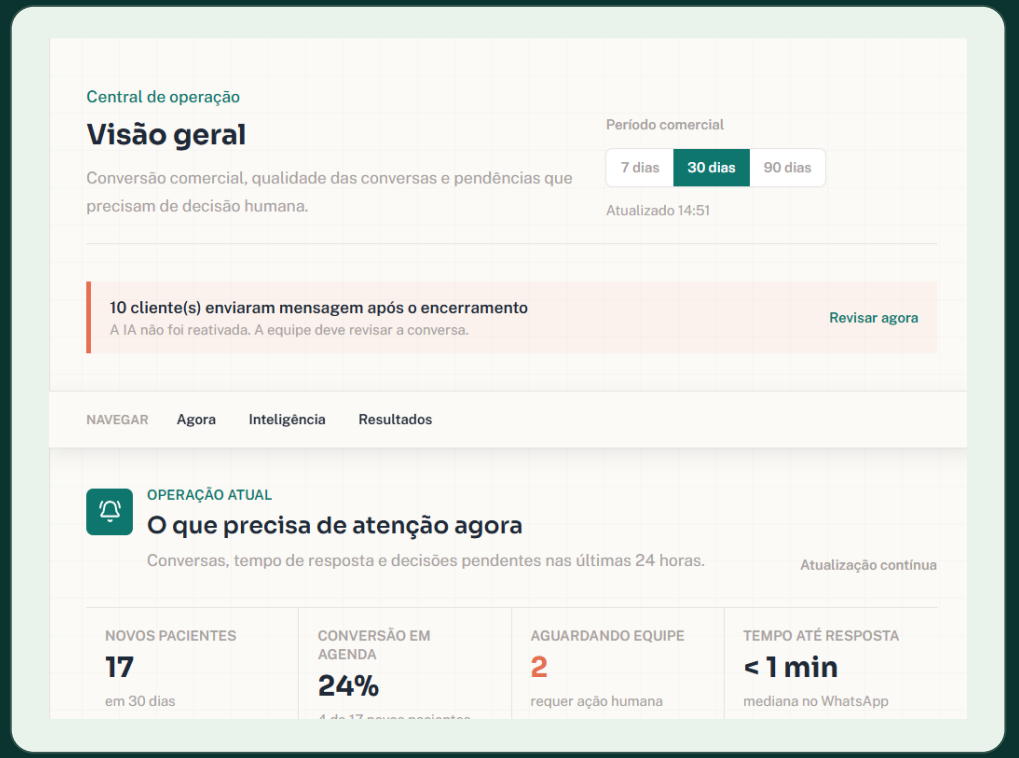
Do produto à startup relevante

Oria

Uma secretária administrativa que transforma mensagens em agenda — e prova o valor entregue.

ANÁLISE + PRODUTO + PLANO

14 outubro 2026
Base: v1.md + produto autenticado + fontes verificadas



A oportunidade é uma operação resolvida. Não mais um chatbot.

Tese recomendada: automação administrativa para clínicas particulares, com equipe no controle.

FOCAR

Uma especialidade, uma cidade, um fluxo de consultas e retornos. Comprador: dono ou gestor.

COMPLETAR

Mensagem → disponibilidade → confirmação → acompanhamento. Exceções chegam à recepção com contexto.

PROVAR

Comparar agenda, retrabalho e custo com a linha de base. Cobrar pelo valor demonstrado, não pela novidade da IA.

HIPÓTESE DE NEGÓCIO

Meta de 90 dias: 5 pilotos bem delimitados → pelo menos 3 clientes pagantes.

A base técnica parece suficiente para testar a tese. Demanda, confiabilidade e replicação ainda não estão provadas.

O v1 acerta o recorte.
Mas ainda não fundamenta uma decisão de investimento.

Separar uma boa tese de evidências de produto, demanda, preço e capacidade de execução.

MANTER

Clínicas primeiro; escopo administrativo; handoff real; conhecimento aprovado; prova de resultado.

CORRIGIR

“Ambient intelligence” de US$82,1 bi não mede este mercado. Médicos e beneficiários também não são clínicas compradoras.

VALIDAR

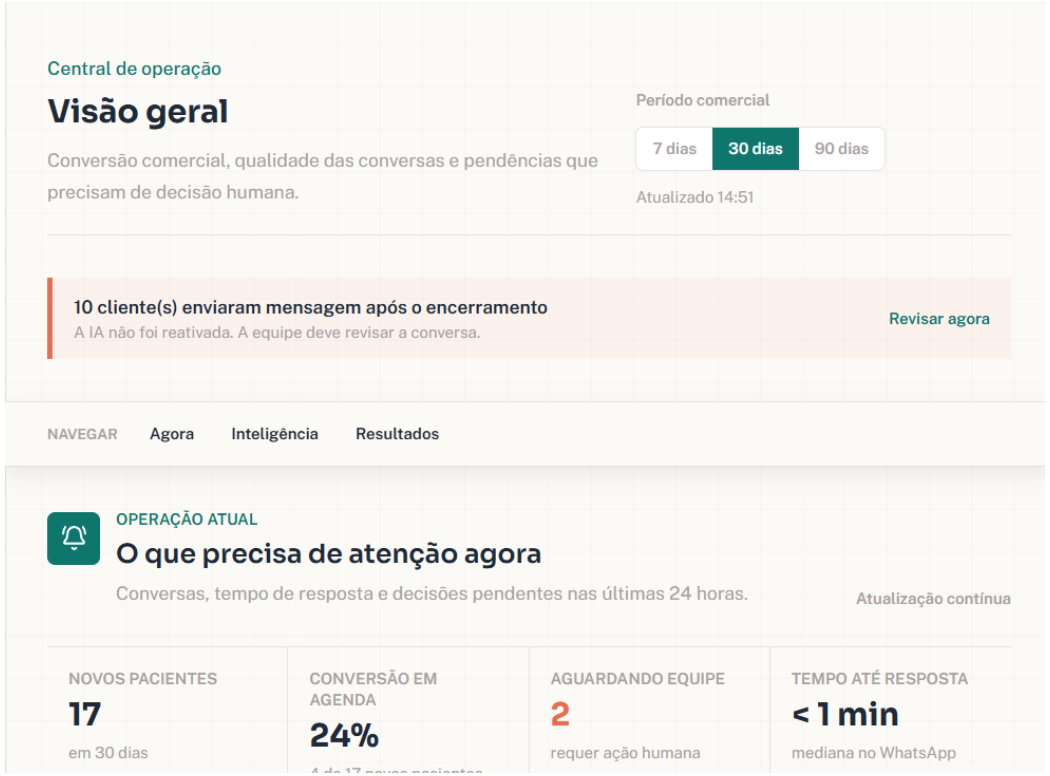
Checklist ≠ gap observado. Faixas de preço ≠ disposição a pagar. WhatsApp ≠ canal escolhido sem entrevista.

RETIRAR DA PROMESSA

−30% de faltas sem evidência robusta; métricas internas sem origem pública; “LGPD compliant” e ROI garantido.

A Oria já tem uma superfície operacional. O próximo salto é confiabilidade e repetição.

Captura real do dashboard. A existência da interface não demonstra resultado comercial.



OBSERVADO NO PRODUTO

- Dashboard: conversão, fila humana e resposta.
- Navegação: conversas, clientes e calendário.
- Backend: agenda, cadastro, sinal Pix e políticas.
- Arquitetura: worker, ferramentas e trilha de execução.

Não observado nesta análise: agendamento, pagamento ou mensagem enviados end-to-end. Rotas secundárias apresentaram carregamento persistente no navegador de inspeção.

17 novos pacientes não são PMF. Mas revelam onde medir e investigar.

Período de 30 dias no dashboard observado; agregados, sem dados pessoais.

17

Novos pacientes

Definição ainda precisa de auditoria

4 / 17

Com agendamento

23,5% → interface mostra 24%

2

Aguardando equipe

Fila não equivale a SLA cumprido

10

Mensagens pós-encerramento

Alerta de revisão humana

Investigar antes de apresentar como tração

Coorte e janela • atribuição do agendamento • duplicidades • denominadores • continuidade após encerramento

"< 1 min" de resposta é um sinal operacional; não prova resolução, receita incremental ou satisfação.

Sete capacidades habilitadas.
Não é necessário reconstruir o núcleo.

API autenticada confirma configuração ativa; código permite qualificar o nível de evidência.

CADASTRO

Classificar novo/retorno
Atualizar perfil

AGENDA

Buscar horários • reservar
Confirmar • reagendar

PAGAMENTO

Solicitar sinal Pix
Pré-requisitos configuráveis

1

Plano de agendamento

Configuração observada

2

Tipos de evento agendáveis

Não é contagem de especialidades

9

Regras de coleta de dados

Rever necessidade de cada campo

Presença no código, operação validada e prontidão SaaS são coisas diferentes.

O “mínimo” deve fechar os gaps relevantes, sem rotular tudo como recurso ausente.

Superfície	Evidência atual	Próximo passo
Agenda + sinal Pix	Ferramentas e regras presentes	Testar conflito, retries e confirmação real
Handoff + fila	Política e alerta observados	Medir aceite, contexto e tempo de retomada
Áudio + follow-up	Implementação documentada	Verificar modelo, entrega e janela de 24h
Cancelamento pela IA	Não consta no registro consultado	Adicionar ação determinística + auditoria
Resultado por interação	Logs e métricas já existem	Unificar coorte, eventos e custo por resultado
Multi-clínica + governança	Configuração ativa por banco	Validar isolamento antes de compartilhar dados

Prioridade: testar e completar a cadeia operacional; não criar novas telas só para aumentar a percepção de escopo.

O1 · Oria — dashboard autenticado | O2 · Oria — API autenticada do Agent Studio | C1 · Código — arquitetura e ferramentas | C2 · Código — configuração ativa e follow-up

O contexto brasileiro é grande.
O mercado comprável ainda precisa ser delimitado.

Números de contexto — não uma multiplicação automática para construir TAM.

53,06 mi

Vínculos em planos médicos

ANS • junho/2026 • não pessoas únicas

353 mil

Médicos especialistas

FMUSP • dezembro/2024 • não clínicas

92%

Estabelecimentos com sistema eletrônico

TIC Saúde 2024 • públicos + privados

~4%

Estabelecimentos que usam IA

TIC Saúde 2024 • indicador amplo

Implicação: integrar-se ao sistema existente e vender um resultado simples; não pressupor ausência de software.

S1 · NIC.br / CGI.br — TIC Saúde 2024 | S2 · FMUSP — Demografia Médica no Brasil 2025 | S3 · ANS — Dados Gerais

O maior obstáculo pode ser prioridade. Não a qualidade do modelo.

Razões declaradas pelos estabelecimentos que não usam IA; respostas não são mutuamente exclusivas.



Venda recomendada

“Quantos contatos ficaram sem agenda e quanto isso custa?”
É melhor do que “Sua clínica precisa de IA”.

Escolha o comprador antes de escolher mais recursos.

Hipótese de partida alinhada à agenda em etapas já existente; confirmar nas primeiras entrevistas.

HIPÓTESE DE ICP

Clínicas particulares de consulta + avaliação (ex.: nutrologia), para pacientes adultos.

- 2–6 profissionais; dono ou gestor decide.
- ≥ 500 contatos administrativos por mês.
- Agenda com capacidade e perdas recuperáveis.
- Equipe disponível para supervisionar exceções.

ENTRAR SÓ SE

Autoriza medir a linha de base, dá acesso à agenda e aceita definir valor por atendimento realizado.

EVITAR NO PILOTO

Hospitais, convênios complexos, menores de idade e autonomia clínica. Não são necessários para provar a tese.

A concorrência real já controla a agenda, o orçamento ou a conversa.

Não confundir uma lista de empresas de IA com alternativas que o comprador realmente considera.

SOFTWARE DA CLÍNICA

Feegow / Doctoralia, iClinic, Amplimed, Ninsaúde.
Vantagem: base instalada, agenda e prontuário.

AUTOMAÇÃO DE ACESSO

Hyro, Orbita, Avaamo, Kore.ai.
Vantagem: resolução integrada e contratos de escala.

IA CLÍNICA E ENTERPRISE

Abridge, Dragon Copilot, Nabla, Suki, Ambience.
Vantagem: workflow clínico; adjacências em expansão.

SUBSTITUTOS ECONÔMICOS

Recepção humana, call center, WhatsApp Business e automações genéricas.
Vantagem: hábito e custo já conhecidos.

Oria precisa mostrar valor incremental sobre o software existente — e não pedir sua substituição.

D1 · Documento de partida — v1.md | S4 · Feegow — Preços e Planos | S6 · Hyro — comunicado de financiamento | S8 · Abridge — site e posicionamento atuais

O software clínico já cabe no orçamento. Uma segunda assinatura precisa justificar-se.

Captura real da página de preços em 14/10/2026; valores exibidos por profissional/mês.



PREÇO PÚBLICO OBSERVADO

R$129 / 199 / 249

Starter / Plus / VIP
por profissional, por mês

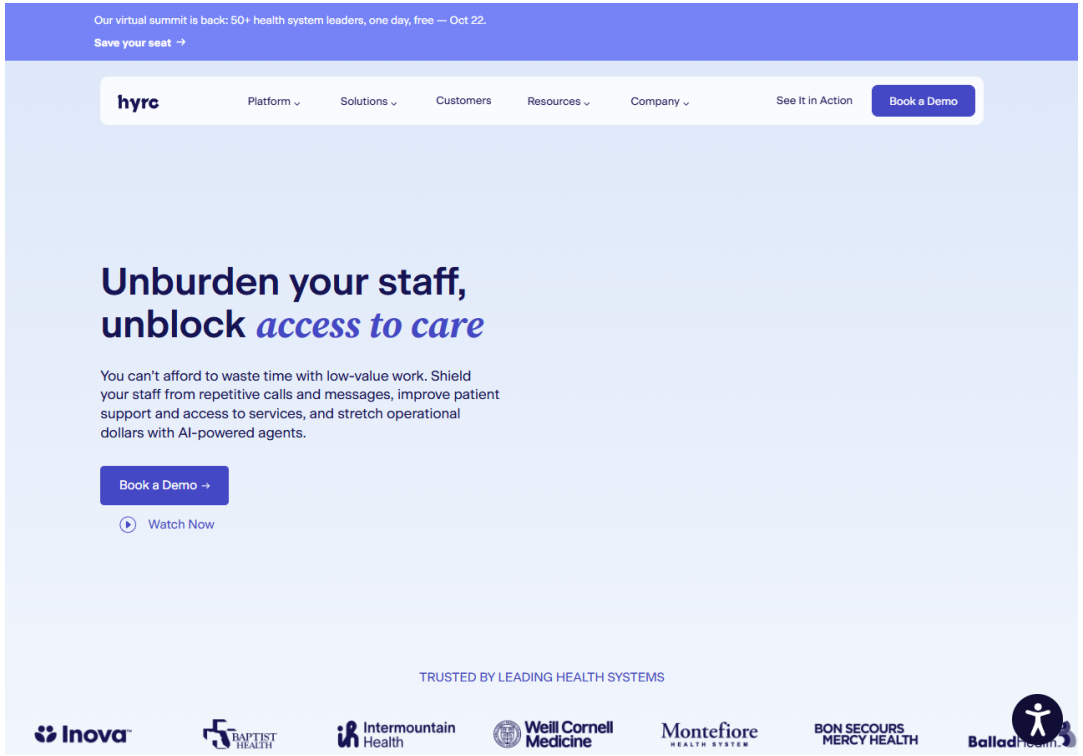
5 profissionais no Plus

5 × R$199 = R$995/mês

Não há equivalência de funções: é uma âncora de orçamento, não comparação “mais barato”.

Hyro ensina a vender resolução. Não “uma IA que conversa”.

Interface real do site; escala e resolução são claims do fornecedor, com data explícita.



US$95 mi

Capital total anunciado

Rodada de US$45 mi • out/2025

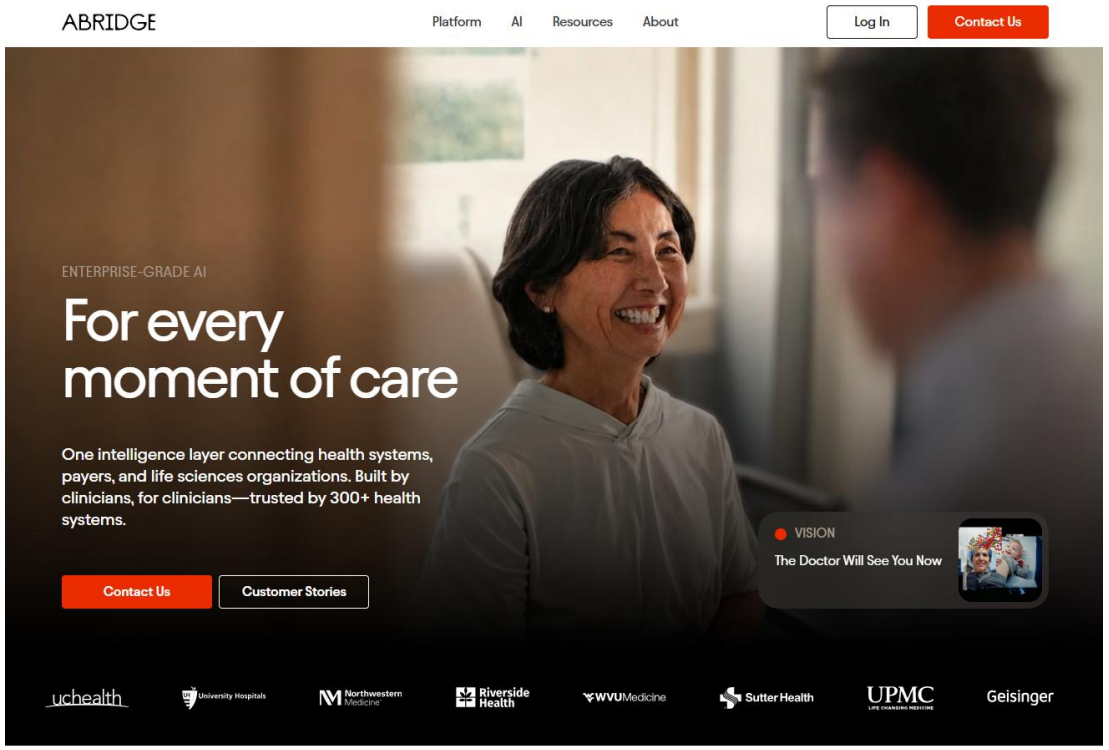
Até 85%

Resolução de rotina alegada

Claim; não meta automática da Oria

A IA clínica está virando plataforma. Isso torna o foco ainda mais importante.

Abridge não é preço comparável para a Oria; é um sinal de expansão competitiva.



300+

Sistemas de saúde no site

Claim atual • captura out/2026

100 mi+

Conversas por ano no site

Claim atual; não dado da rodada

O posicionamento precisa caber em uma frase — e em uma demonstração.

Proposta recomendada; só publicar claims de resultado depois de medi-los.

“A Oria transforma mensagens no WhatsApp em consultas confirmadas e retornos organizados.”

DEMONSTRAR

Pedido realista → opções válidas → escolha explícita → confirmação → próxima ação rastreável.

NÃO PROMETER

Diagnóstico; substituição da recepção; fim das faltas; conformidade certificada; receita garantida.

Co-piloto da recepção com autonomia delimitada, não “médico digital” nem novo prontuário.

WhatsApp + português são requisitos. A defesa está no workflow e na distribuição.

A tecnologia do modelo é copiável; implantação repetível e resultados específicos são mais difíceis de copiar.

01 Configurar uma clínica

Perfil, regras e integração

→

02 Concluir a jornada

Agenda + pagamento + handoff

→

03 Medir resultados

Eventos próprios e coortes

→

04 Replicar no nicho

Onboarding e canal previsíveis

Ativo defensável: dados operacionais consentidos + integração estável + playbook por especialidade.

Seis ajustes para um piloto cobrável. Não seis novos módulos de produto.

Estimativa de engenharia para a base atual; não inclui uma reescrita multi-tenant nem integrações complexas.

01 Perfil de clínica reutilizável

Configurar/exportar regras e reduzir coleta • 1–2 dias

02 Fechar ciclo de agenda

Cancelamento + testes de conflito/retry • 3–5 dias

03 Retomada e confirmação

Templates, opt-out e janela de 24h • 3–5 dias

04 Métricas por resultado

Unificar ledger, coorte e custo • 3–4 dias

05 Handoff com responsável

Aceite, resumo, prazo e reentrada • 2–3 dias

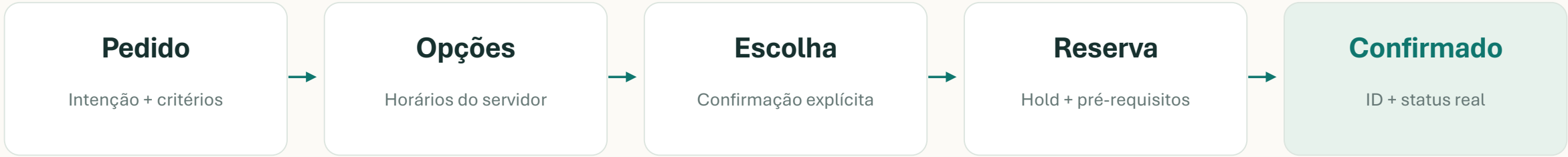
06 Kit de implantação e confiança

Avisos, contratos e rotinas de direitos • 3–5 dias

Total proposto: 15–24 dias de engenharia. Conector externo: +5–10 dias, se a API existir; jurídico e isolamento são gates.

A conversa pode ser flexível.
A agenda precisa ser determinística.

Fluxo proposto: reutilizar busca, hold, confirmação e reagendamento; completar cancelamento.



EXCEÇÃO ≠ CONFIRMAÇÃO

Sem vaga, ferramenta indisponível ou sinal não confirmado: explicar o estado real e encaminhar sem inventar sucesso.

ADICIONAR: CANCELAMENTO

calendar.cancel com escolha explícita, autorização, regra de prazo, liberação única da vaga e log do resultado.

Aceite técnico: retries não duplicam eventos; concorrência não vende a mesma vaga; nenhum "agendado" sem persistência.

Encaminhar é uma ação operacional. Não apenas uma frase do assistente.

Proposta de fluxo, não screenshot de uma funcionalidade nova.

QUANDO PARAR

Exceção operacional; informação não aprovada; demanda clínica; solicitação explícita de humano.

O QUE ENTREGAR

Resumo + pedido + campos necessários + última ação + motivo + responsável + prazo de retorno.

COMO RETOMAR

Equipe aceita a fila; define estado; paciente recebe confirmação; reentrada da IA é explícita.

Janela de 24h no WhatsApp

Nova mensagem reinicia a janela. Fora dela: template aprovado quando permitido; opt-out e categoria corretos. Não estender o follow-up atual “na força”.

Medir handoff aceito, tempo de espera e rework. O alerta de pós-encerramento pede regra explícita de continuidade.

Meça o que termina.
Não apenas mensagens que começam.

Unificar a auditoria existente em um registro operacional por episódio e por agendamento.

Evento	Estado verificável	Métrica derivada
Contato recebido	ID, clínica, coorte, intenção elegível	Volume e abandono (sem excluir silêncios)
Horário oferecido	Opções autoritativas + fonte	Tempo até primeira resposta útil
Agendamento persistido	ID + confirmação + recurso	Conversão sem dupla contagem
Handoff solicitado/aceito	Motivo + responsável + timestamps	Aceite, SLA e retrabalho
Consulta realizada / falta	Estado confirmado pela clínica	Contribuição incremental / no-show
Custo registrado	Modelo, tokens, canal, correções	Custo por resolução e por cliente

Taxa de resolução automática: episódios administrativos concluídos sem rework ÷ todos os episódios elegíveis iniciados.

O mínimo comercial inclui confiança. Não é um item para “depois do PMF”.

Requisitos de produto e operação; revisão jurídica especializada continua necessária.

ESCOPO E DADOS

Só administração. Perfil aprovado; finalidade por campo; identidade; acesso restrito; minimização do conteúdo no canal.

OPERAÇÃO E DIREITOS

Papéis e contratos; retenção; exportação/eliminação; logs; resposta a incidente; subprocessadores e transferências.

ISOLAMENTO DE CLÍNICAS

Configuração ativa é singleton por banco no código consultado. Separação SaaS não foi demonstrada nesta análise.

Gate de expansão

Antes do segundo cliente: provar segregação de dados, permissões, backups e recuperação. Instâncias isoladas só servem de piloto se o isolamento for realmente verificado.

R$1.140/mês precisa comprar mais de R$1.140 de valor verificável.

Simulação de uma clínica; os parâmetros abaixo precisam ser substituídos por dados do piloto.

CENÁRIO, NÃO RESULTADO

800

Contatos elegíveis / mês

Hipótese de volume

30% → 35%

Conversão em agenda

Ganho de 5 pontos percentuais

R$150

Margem por consulta realizada

Não receita bruta

800 × 5 p.p. × 80% de comparecimento × R$150 = R$4.800/mês

Custo simulado: R$990 + R$150 de canal → saldo incremental R$3.660/mês; benefício/custo ≈ 4,2×.

O resultado é muito sensível à capacidade, comparecimento e margem.

Faltas e carga da recepção são alavancas alternativas ou complementares só depois de deduplicar eventos.

Ganho de conversão	Consultas extras realizadas	Valor incremental	Saldo após R$1.140
+1 p.p.	800 × 1% × 80% = 6,4	R$960	−R$180
+3 p.p.	800 × 3% × 80% = 19,2	R$2.880	R$1.740
+5 p.p.	800 × 5% × 80% = 32	R$4.800	R$3.660

FALTAS — CENÁRIO SEPARADO

600 agendamentos; 15% → 11% de faltas = 24 consultas recuperadas. A R$150: R$3.600 de contribuição.

TEMPO — CAPACIDADE, NÃO CAIXA

600 tarefas × 3 min × 50% resolvidas = 15 h/mês. A R$30/h: R$450 de capacidade estimada.

Teste uma oferta de clínica.
Não quatro planos antes de aprender.

Preço de experimento, não preço validado de mercado nem compromisso comercial.

PREÇO A TESTAR

R$990

/ clínica / mês + consumo do canal

Operação administrativa + agenda + handoff + métricas.
Limites e serviços definidos em contrato.

- Piloto de 30 dias com baseline e escopo escrito.
- Cobrança por clínica; não esconder implantação.
- Mensagens e provedor com franquia ou repasse claro.
- Integração externa cotada depois de discovery.
- Teste R$790 vs R$990 vs R$1.490 em propostas reais.

Não comparar diretamente com R$199/profissional de um prontuário: são funções e unidades de cobrança diferentes.

D1 · Documento de partida — v1.md | S4 · Feegow — Preços e Planos | S9 · WhatsApp — preços da plataforma

A margem precisa sobreviver a mensagens, retries e suporte humano.

Orçamento ilustrativo por clínica; antes de impostos, CAC, inadimplência e despesas fixas.

Componente	Valor simulado	Como validar
Assinatura SaaS	R$990	Contrato e pagamento, não intenção de compra
Consumo de canal repassado	R$150	Categoria, templates, BSP e fatura real
Custo de canal	−R$150	Não confundir repasse com ARR SaaS
Modelos / infra / suporte	−R$40 / −R$40 / −R$100	Tokens, tempo de equipe e custo alocado

R$810

Margem bruta mensal

R$1.140 faturado − R$330 de custo

71,1%

Margem sobre fatura total

SaaS isolado: 81,8%

54,4%

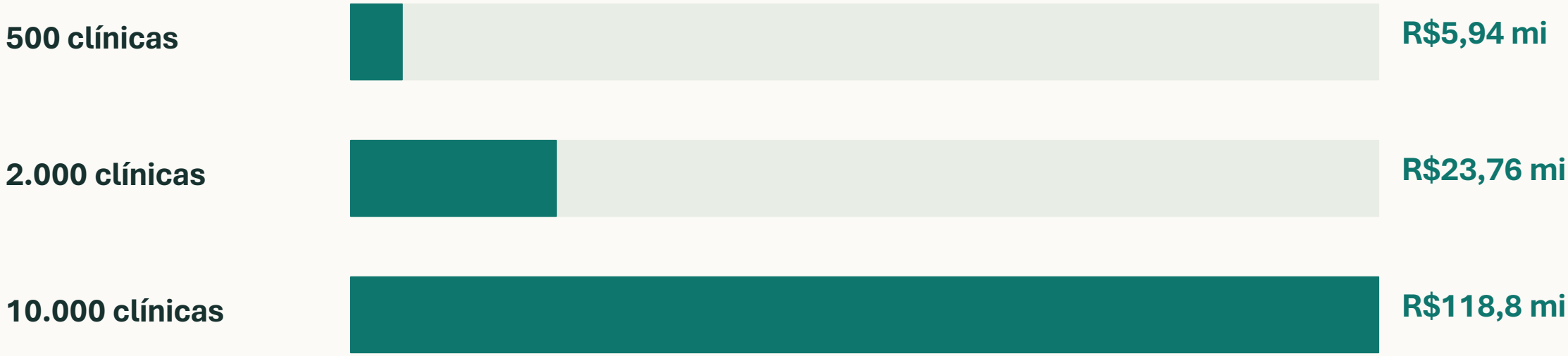
Se suporte sobe a R$290

Mesmos outros custos; cenário de stress

S9 · WhatsApp — preços da plataforma | S10 · Microsoft Learn — Advanced Messaging pricing

Há caminho para receita relevante. Isso ainda não é um TAM validado.

Cenários de ARR SaaS a R$990/mês; excluem consumo repassado, descontos, churn e inadimplência.



100 clientes = R$1,188 mi de ARR. 3 pagantes no piloto = R$2.970 de MRR; prova inicial, não PMF.

O canal inicial é o fundador.
O funil inicial cabe numa planilha.

Metas de atividade e aprendizado — não um pipeline já existente.

50	→	15	→	8	→	5	→	3
Clínicas-alvo		Entrevistas com decisores		Workflows elegíveis		Pilotos contratados		Clientes pagantes

A entrevista que importa

Mostrar 20 pedidos anonimizados; quantificar perdas; verificar acesso à agenda; entender quem paga e como aprova a compra.

Evitar piloto grátis infinito. Registrar motivo de "não", tempo de onboarding e disposição real a pagar.

90 dias para validar a cadeia.
Não para construir uma plataforma inteira.

Uma frente técnica, uma frente comercial e revisão jurídica em paralelo.

D0–14

Recorte + baseline

15 entrevistas; acesso à agenda; 14 dias de linha de base; gates de dados.

D15–35

Fechar gaps + shadow

6 ajustes mínimos; casos sintéticos; integração; recepção aprova ações.

D36–60

Pilotos + cobrança

5 clínicas; ativação gradual; propostas reais; revisão semanal de eventos.

D61–90

Renovar + decidir

≥3 pagantes; avaliar onboarding, margem, qualidade e renovação 30–60d.

Retenção de 90 dias por cliente ainda não estará madura no D90 se a cobrança começar no D36: avaliar a partir do D126.

Cinco pilotos geram aprendizado.
Uma amostra maior sustenta as promessas.

Metas propostas. Definir coortes, elegibilidade e método antes de ligar a automação.

Pergunta	Métrica / desenho	Meta de avanço
Converte melhor?	Conversão 30% → 35%, grupos comparáveis	~2.800 contatos no total como referência*
Agenda com segurança?	Falhas por mutação; retries e concorrência	0 erros em ≥600 ações: limite superior ~0,5%**
Alivia sem criar rework?	Resolução automática / todos elegíveis	≥50% resolvidos; retrabalho ≤10%
Equipe aceita o handoff?	Aceite + resumo + tempo de resposta	≥90% aceitos; SLA definido por clínica
Comprador paga e renova?	Aceite de proposta + fatura + renovação	≥3/5 pagam; renovação 30–60d observável

* Aproximação: teste bilateral 5%, poder 80%, grupos independentes equilibrados. Cluster, sazonalidade e deduplicação podem exigir mais.
** Regra de três com zero eventos; não prova ausência de risco. Incidente grave suspende a autonomia.

A decisão de continuar deve ser definida antes de ver os resultados.

Não confundir muitos chats, uma demo bonita ou pilotos gratuitos com produto–mercado.

CONTINUAR

≥3/5 pagam; renovação inicial; valor > custo; onboarding ≤1 dia útil; operação sem incidente grave.

AJUSTAR O RECORTE

Há dor e pagamento, mas um workflow, preço ou conector concentra falhas. Reduzir escopo e repetir a coorte.

PAUSAR / PARAR

Sem acesso à agenda; equipe refaz ações; custo excede valor; indisponibilidade recorrente; risco clínico ou dados não controlados.

METAS — NÃO ESTADO ATUAL

Se os gates passam: expandir dentro do mesmo nicho antes de adicionar outra categoria de produto.

O trabalho desta semana é obter acesso, baseline e compromisso.

A menor próxima ação deve reduzir uma incerteza comercial ou operacional.

Quando	Responsável	Entregável persistente
D1	Fundador / produto	Definir 1 ICP, 1 workflow e 50 clínicas-alvo
D1–2	Engenharia	Diagnosticar carregamento das rotas; walkthrough estável
D2–3	Fundador / operações	Agendar 15 entrevistas; obter 3 acessos à agenda
D2–4	Engenharia	Contrato de eventos, baseline e testes de isolamento
D3–5	Jurídico / responsável clínico	Escopo, dados, contratos e textos aprovados
D5–7	Fundador / cliente	2 acordos de piloto com preço e critério de sucesso

Não começar com novo modelo, novo dashboard ou 10 conectores. Começar com uma clínica que aceita medir e pagar.

Menos produto novo.
Mais prova de valor.

A tese merece um piloto pago.
Ainda não merece uma promessa de PMF.



01 Completar agenda e continuidade.
02 Medir contribuição, custo e retrabalho.
03 Replicar com segurança no mesmo nicho.

Apêndice / premissas e fórmulas

Todos os cenários financeiros são ilustrativos; substituir entradas por valores observados no piloto.

Modelo	Entradas	Cálculo / limite
Valor de conversão	800 contatos; +5 p.p.; 80% show; R$150 margem	800 × 0,05 × 0,80 × 150 = R$4.800
Break-even de conversão	Custo R$1.140; mesmas outras entradas	1.140 ÷ (800 × 0,80 × 150) = 1,19 p.p.
No-show (cenário separado)	600 agendados; 15% → 11%; R$150 margem	600 × 0,04 × 150 = R$3.600
Capacidade liberada	600 tarefas; 3 min; 50% resolução; R$30/h	15 h; R$450 de capacidade — não caixa
ARR SaaS	N clínicas; mensalidade R$990	N × 990 × 12; excluir repasse de canal
Margem bruta total	Fatura R$1.140; custo R$330	(1.140 − 330) ÷ 1.140 = 71,1%

Causalidade, capacidade disponível e deduplicação importam mais do que uma simulação com muitas casas decimais.

Apêndice / “pronto” precisa ser testável

Backlog proposto, com reuso explícito da implementação existente.

Mudança	Reuso	Aceite mínimo
Perfil de clínica	Configuração / regras do agente	Exportar/importar sem segredo; fonte aprovada; campos por finalidade
Agenda completa	find_slots / hold / book / reschedule	Cancelar sem duplicação; conflito/retry/timezone cobertos
Continuidade	Follow-up / templates / fila	Status real; janela 24h; opt-out; mensagens após encerramento
Ledger de resultado	Runs, steps e dashboard existentes	Denominadores estáveis; appointmentId; custos; abandono incluído
Handoff	Política e estado human_handoff	Responsável e aceite; contexto; SLA; reentrada sem contradição
Confiança / implantação	Infra e controles existentes	Isolamento provado; acessos; direitos; backup/restauração; contratos

Apêndice / mapa de players do v1

Mapa de categorias, não comparação validada feature a feature de 25+ fornecedores.

Categoria	Referências	Uso na decisão da Oria
Acesso / conversa	Hyro, Orbita, Avaamo, Kore.ai	Resolução, integração e contextual handoff
Documentação clínica	Dragon Copilot, Abridge, Suki, Nabla, Ambience	Evitar a disputa enterprise; observar adjacências
Outros clínicos / infra	DeepScribe, Augmedix, ThinkAndor, Epic AI Charting, HealthScribe	Não construir prontuário ou ambient scribe no piloto
Navegação / cuidado	Pager, K Health, Lark, Teladoc	Cuidado e triagem mudam escopo e risco
Plataformas enterprise	Copilot Studio, Salesforce, NICE, Genesys, Cognigy, Amelia	Governança e canais como baseline; não feature parity
Brasil / substitutos	Feegow/Doctoralia, iClinic, Amplimed, Ninsaúde; recepção e bots	Agenda instalada, budget e custo de mudança

Fontes / mercado e comparação brasileira

URLs clicáveis. Datas e denominadores preservados; notas de cada slide trazem a proveniência completa.

S1
TIC Saúde 2024 — NIC.br / CGI.br
92%, ~4%; barreiras 61/59/49%; amostra nacional; campo fev–ago/2024.

S2
Demografia Médica 2025 — FMUSP
353.287 especialistas; base dezembro/2024. Não é contagem de clínicas.

S3
Dados Gerais — ANS
53.055.406 vínculos; competência junho/2026; atualização agosto/2026.

S4
Preços e Planos — Feegow
R$129 / R$199 / R$249 por profissional/mês; captura 14/10/2026.

S5
Site institucional — Feegow
Escala divulgada pelo fornecedor; claims, não censo nem TAM.

Fontes / produto, plataformas e limites

Capturas reais em 14/10/2026. Os gráficos e tabelas de cenário são editáveis, não screenshots.

S6 **Hyro — comunicado 21/10/2025**

US$45 mi na rodada; US$95 mi total; até 85% é claim do fornecedor.

S7 **Nabla — comunicado junho/2025**

US$70 mi Série C; US$120 mi total; contexto clínico, não preço local.

S8 **Abridge — site atual**

300+ sistemas, 100 mi+ conversas/ano: claims atuais, não auditoria.

S9 **WhatsApp — regras de preço e janela**

Serviço dentro de 24h; categorias e provedor devem ser modelados.

S10 **Microsoft Learn — preço ACS**

US$0,005 por mensagem só se usar ACS; não custo obrigatório da Oria.

O1/O2: dashboard e API autenticada em leitura. C1/C2: código local. D1: v1.md. Sem teste operacional end-to-end, entrevistas ou faturas.
L1/L2: referências legais identificadas; texto integral não recuperado. Revisão jurídica e CFM pendentes.